2022-2023

Praktijkleerplan Kindergeneeskunde

Jonker-Kruizenga, Eline

23-03-2023

Inhoudsopgave

Leerroute ……3

Eerste praktijkperiode

MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag/midden complexe zorgvraag (KERN)……4
MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag (KERN)……6
MK-KIN-2 Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag-/ midden complexe zorgvraag (KERN)……8

Tweede praktijkleerperiode

MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie (KERN)……..10
MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag-/midden complexe zorgvraag (KERN)……12
MK-KIN-4 Zorg verlenen aan een kind met psychosociale, psychosomatische of psychiatrische problematiek (KERN)……14

Leerroute Opleiding Kinderverpleegkundige

De opleiding wordt verdeeld in twee praktijkperiodes van ongeveer 6 maanden. De tijd is echter flexibel en kan naar gelang de voortgang verlengd of verkort worden. De gemiddelde duur van de opleiding is 1 jaar.
Aan het begin van elke praktijkperiode beschrijft de student één persoonlijk leerdoel dta SMART beschreven is.

Eerste praktijkperiode*

- MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag/midden complexe zorgvraag (KERN)
- MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag (KERN)
- MK-KIN-2 Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag- /midden complexe zorgvraag (KERN)

Aan het eind van deze praktijkperiode zorgt de student voor een 360 graden feedback met betrekking tot alle drie de EPA's. Dit dient samen met de andere bewijzen in het portfolio minimaal 1 week voor de beoordelingsdatum ingeleverd zijn.

Tweede praktijkleerperiode*

- MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie (KERN)
- MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag-/midden complexe zorgvraag (KERN)
- MK-KIN-4 Zorg verlenen aan een kind met psychosociale, psychosomatische of psychiatrische problematiek (KERN)

Aan het eind van deze praktijkperiode zorgt de student voor een 360 graden feedback met betrekking tot alle drie EPA's. Dit dient samen met de andere bewijzen in het portfolio minimaal 1 week voor de beoordelingsdatum ingeleverd zijn.

Afronden opleiding

Aan het eind van de tweede praktijkperiode schrijft de student een metareflectie en zal er een portfolioscan plaatsvinden door de Praktijkopleider.

*leerroute kan anders opgebouwd zijn, dit is afhankelijk van de leerroute die je via Erasmusacademie volgt.

Titel	MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag/midden complexe zorgvraag (KERN)
Versie	definitief, © maart 2022
Specificaties & beperkingen	Het betreft het verlenen van zorg aan een kind met een laag-midden complexe zorgvraag, waarbij de uitvoering van protocollaire basiszorg, ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg centraal staan. Bij laag complexe zorg is er sprake van een enkelvoudige voorspelbare zorgvraag. De overgang van laag- naar midden complex is een vloeiende: de kans op complicaties neemt toe, maar blijft gering. Bij midden complexe zorg is er sprake van een meervoudige zorgvraag (twee problemen die elkaar beïnvloeden). Het kind kan beperkt inzicht hebben in de eigen gezondheidssituatie en ouders kunnen extra ondersteuning nodig hebben. Het verloop van de opname kan minder voorspelbaar worden. **In de volgende context:** ● Kind vanaf 28 dagen tot 18 jaar in alle ontwikkelingsfasen ● Ouders/gezin rondom het kind ● Intra- en extramurale setting **De activiteit omvat:** ● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens ● Afnemen van een (hetero)anamnese gericht op het kind en het gezin ● Methodisch observeren, meten en beredeneren/interpreteren van de vitale functies van het kind en het invullen van de scorelijsten en op basis daarvan handelen ● Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de kinderverpleegkundige zorg, op basis van ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg ● Ondersteunen van het kind en de ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making (Samen beslissen over zorg) ● Herkennen en interpreteren van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en op basis daarvan handelen ● Overdragen/indiceren van zorg en samenwerken binnen het inter- en multidisciplinaire netwerk
Voorwaardelijkheden	Deze EPA wordt gezien als basis voordat de andere KIN-EPA's kunnen worden afgerond tenzij de student start met de EPA's rondom de pasgeborene
CanMEDS	☒ Vakinhoudelijk handelen ☒ Communicatie ☒ Samenwerking ☒ Kennis en wetenschap ☒ Maatschappelijk handelen ☒ Leiderschap ☒ Professionaliteit
Kennis	● Anatomie en fysiologie van het kind (w.o. kennis van normaalwaarden/ vitale functies bij kinderen) ● Normale groei en lichamelijke ontwikkeling, voeding en dag-/nachtritme van het kind van 0-18 jaar ● Ontwikkelingspsychologie bij kinderen in relatie tot ziek zijn en ziekenhuisopname/zorg thuis (o.a. hechting, angst en pijnbeleving) ● Communicatietheorieën en -strategieën over communiceren met kinderen ● Aangeboren, psychomotore en/of cognitieve ontwikkelingsstoornissen ● Pediatric Basic Life Support (PBLS) ● Farmacologie bij kinderen ● Integrale kindzorg (o.a. MKS) en gezinsgerichte zorg, empowerment van kind en gezin ● Sociale situatie rondom kind en gezin, mogelijke kenmerken gezinnen met multiproblematiek (zoals financiële problemen, sociale problemen en middelengebruik) ● Specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot kinderen ● Veilig thuis, meldcode ● Indiceren van zorg ● Jeugdgezondheidszorg, rijksvaccinatieprogramma en screening
Vaardigheden en gedrag	**Vaardigheden:** ● Inrichten en controleren van de werk/leefomgeving waar de zorg plaatsvindt gericht op de ontwikkelingsfase en de veiligheid van het kind ● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens

	● Methodisch observeren, meten en beredeneren/interpreteren van de vitale functies van het kind ● Op basis van klinisch redeneren prioriteiten stellen en hiernaar handelen. ● Observeren gezondheidstoestand (somatisch en psychosociaal), signaleren vooruitgang of verslechtering en daarop handelen ● Toepassen van de principes en benaderingswijze van ontwikkelingsgerichte - en gezinsgerichte zorg ● Uitvoeren van ADL/basiszorg afgestemd op de ontwikkelings- en leeftijdsfase van het kind in afstemming met kind en ouders ● Afstemmen van communicatie met het kind en ouders, rekening houdend met de ontwikkelings- en leeftijdsfase van het kind ● Verpleegkundig rekenen in de kindzorg ● Toedienen medicatie (incl vaccinatie) ● Begeleiden bij veilig mobiliseren en transporteren van het kind ● Bevorderen van hechting tussen kind en gezin ● Signaleren van afwijkingen in groei en ontwikkeling ● Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld ● Organiseren en coördineren van de uitvoerende zorg ● Interprofessioneel communiceren, samenwerken en zorg afstemmen ● Evalueren en bijstellen van de verpleegkundige zorg ● Afronden van en/of overdragen van zorg intra- en extramuraal **Gedrag:** ● Laat voorbeeldgedrag zien ● Toont empathie ● Kan reflecteren op eigen handelen in de specifieke zorgsituatie ● Kent de eigen verantwoordelijkheid als gespecialiseerd verpleegkundige en de grenzen hiervan ● Staat open voor feedback ● Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp ● Werkt nauwkeurig
Toetsinstrumenten	Leeromgeving: • Monitor Philips MP20 • Werken met meldcode • Subcutaan injecteren • Intramusculair injecteren • Rekentoets • PBLS • Hielprik kinderafdeling Mondeling of schriftelijk uitwerking van 3 ziektebeelden. Keuze uit: • Faillure to thrive, Koemelk-allergie, Gastro-enteritis, RS-virus, Reflux, Scoliosis, Trauma Capitis Vaardigheidstoetsen: • Vaccinatie • PKU KPE/Feedback/CBD: minimaal 6
Fase en niveau	De verwachting is dat de student deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden.

Titel	MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag (KERN)
Versie	Definitief, © maart 2022
Specificaties & beperkingen	Het betreft een laag- of midden complexe zorgsituatie: ● Pasgeborenen vanaf 35 weken zwangerschapsduur tot 28 dagen post à terme datum met een gewicht boven 2 kg. Laag complexe zorg betreft een stabiele situatie van de pasgeborene waarin geen of beperkt kans is op somatische complicaties en er geen complexiteit in psychische, maatschappelijke, culturele en/of spirituele aspecten in de gezinssituatie te verwachten is. ● De overgang van laag- naar midden complexe zorg is een vloeiende: de kans op somatische complicaties neemt toe en/of er is een toename van complexiteit te verwachten op psychische, maatschappelijke, culturele en/of spirituele aspecten. Het verloop van de zorg blijft in grote mate voorspelbaar. De pasgeborene reageert op de geboden therapie. **Specificaties:** Dit is een kern-EPA voor OBS, HC-IC-N en KIN **De activiteit omvat:** ● Voorbereiden van de opvang(ruimte) en klaarzetten en controleren (bewakings-)apparatuur voor de opvang van de pasgeborene ● Ontvangen, opnemen en/of overnemen van de zorg van de pasgeborene en ouders/naasten ● Methodisch observeren, meten en bewaken van vitale functies van de pasgeborene ● Afnemen van een hetero-anamnese ● Analyseren en interpreteren van alle verzamelde gegevens en op basis van klinisch redeneren prioriteiten in de zorg stellen en deze uitvoeren ● Zorg inrichten en uitvoeren op basis van gezinsgerichte- en ontwikkelingsgerichte zorg ● Informeren, instrueren en begeleiden van ouders/naasten ● Zorg prioriteren op basis van mogelijke complicaties of complexiteit ● Organiseren en coördineren van de uitvoerende zorg ● Interprofessioneel communiceren en samenwerken en de zorg afstemmen met collega's (intra- en extramuraal) ● Evalueren van de verpleegkundige zorg in een cyclisch proces ● Afronden of overdragen van zorg
CanMEDS	☒ Communicatie ☒ Samenwerking ☒ Kennis en wetenschap ☒ Maatschappelijk handelen ☒ Leiderschap ☒ Professionaliteit ☒ Samenwerking
Kennis	● Anatomie en fysiologie: embryologie, ontwikkeling van de pasgeborene vanaf 35 weken zwangerschapsduur tot 28 dagen post á-terme leeftijd, normaalwaarden en afwijkende waarden van de vitale functies en/of uiterlijke kenmerken van de pasgeborene ● Laag/midden complexe pathologie: pathologie bij pasgeborenen bij vanaf 35 weken, genetische afwijkingen, afwijkingen in zwangerschapsduur en gewicht ● Diagnostiek, behandeling en prognose bij de midden complexe pathologie: neonatale screening, rijksvaccinatieprogramma ● Medische technologie die gebruikt wordt bij de pasgeborene ● Methodieken en metingen: NEWS/PEWS, ABCDE en andere scorelijsten ● Effect van medicatie/alcohol en drugsgebruik van moeder tijdens de zwangerschap op de pasgeborene ● Farmacologie- en therapie: farmacologische pijn reducerende interventies, wijze van medicatietoediening ● Specifieke zorgsituaties: gezinsgerichte zorg, ontwikkelingsgerichte zorg en pijn, voeding, sociale kaart

	● Wet- en regelgeving rondom geboorte, rollen, rechten en plichten van ouders, procedures en de rol van de verpleegkundige bij verdenking (kinder)mishandeling en de begeleiding van ouders/ naasten bij zorgen over veiligheid
Vaardigheden en gedrag	**Vaardigheden:** ● Voorbereiden en controleren van de omgeving waar de pasgeborene ligt of opgenomen wordt ● Controleren en bedienen van medische apparatuur in ondersteuning van de zorg aan de pasgeborene ● Ontvangen, opnemen en/of overnemen van de zorg van de pasgeborene en ouders/naasten ● Afnemen (hetero)anamnese ● Toepassen van ontwikkelingsgerichte en gezinsgerichte zorg ● Observeren, meten en bewaken van vitale functies van de pasgeborene ● Analyseren en interpreteren van de gegevens en op basis van klinisch redeneren prioriteren van interventies en deze uitvoeren ● Herkennen en interpreteren van en en anticiperen op fysiologische ontwikkeling en gedragingen, symptomen van pathologische verschijnselen en mogelijke veranderingen in de zorgsituatie ● Uitvoeren van basiszorg van een pasgeborene ● Voorlichting geven aan ouders/naasten over de zorg voor de pasgeborene, in relatie tot het ziektebeeld ● Observeren van hechting en interventies inzetten om hechtingsrelatie te optimaliseren ● Op verschillende wijze toedienen van enterale voeding en begeleiden van ouders hierbij ● Toepassen van verpleegtechnische vaardigheden bij de pasgeborene ● Klaarmaken en toedienen van medicatie ● Voorlichten, instrueren en begeleiding van ouders/ naasten over veiligheid en (afwijkend) gedrag ● Voorlichten van ouders/naasten over de zorg voor een pasgeborene, neonatale screening, rijksvaccinatieprogramma ● Interprofessioneel samenwerken, communiceren en zorg afstemmen ● Ondersteunen van verschillende zorgprofessionals bij handelingen/onderzoeken ● Herkennen van signalen, hanteren van procedures en de rol van de verpleegkundige bij verdenking kindermishandeling en de begeleiding van ouders/naasten bij zorgen over veiligheid ● Evalueren en eventueel bijstellen van de verpleegkundige zorg ● Voorbereiden op en toewerken naar ontslag ● Inventariseren en organiseren van zorg na ontslag ● Overdragen van zorg intra- of extramuraal **Gedrag:** ● Laat voorbeeldgedrag zien ● Toont empathie ● Kan reflecteren op eigen handelen in de specifieke zorgsituatie ● Kent de eigen verantwoordelijkheid als gespecialiseerd verpleegkundige en de grenzen hiervan ● Staat open voor feedback ● Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp
Toetsinstrumenten	Leeromgeving: • Borstvoeding • Kinderafdeling: Philips Centrale bewakingspost • Pompen; infantflow, optiflow • Acute opvang neonaat • Beademing Neopuff Certificaat van deelname aan scholing over borstvoeding door Lakatiekundige Certificaat Menarini behalen middels les over POCT Certificaat EFS scholing KPE/Feedback/CBD: minimaal 6 Vaardigheidstoets: • Sondevoeding toedienen • Dextrose toedienen

	• Inbakeren Observatieverslag van stage op afdeling verloskunde (3 dagen) Mondeling of schriftelijk uitwerking van 2 ziektebeelden. Keuze uit: • Hypoglykemie bij neonaat, Neonatale sepsis, Pneumothorax, Prematuriteit, Dysmaturiteit, Hyperbilirubinemie, Hypothermie
Fase en niveau	De verwachting is dat de student deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden.

Titel	MK-KIN-2 Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag- /midden complexe zorgvraag (KERN)
Versie	definitief, © maart 2022
Specificaties & beperkingen	Het betreft het verlenen van zorg aan een kind dat een enkelvoudige chirurgische ingreep ondergaat zonder co-morbiditeit in de volgende context: ● Kind (0-18 jaar) waarbij vitale functies niet bedreigd zijn ● Ouders/gezin rondom het kind ● Intramurale setting en alleen postoperatief in extramurale setting **De activiteit omvat:** ● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens specifiek gericht op de chirurgische ingreep ● Het afnemen van een (hetero)anamnese specifiek gericht op de chirurgische ingreep ● Methodisch observeren, meten en beredeneren/interpreteren van de vitale functies van het kind in relatie tot de pre- en/of postoperatieve zorg en op basis daarvan handelen ● Voorlichting geven aan kind en gezin met betrekking tot sedatie en de pre- en/of postoperatieve zorg ● Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de kinderverpleegkundige zorg aan een kind o.b.v. ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg ● Overdragen/Indiceren van zorg en samenwerken binnen het intra- en multidisciplinaire netwerk
Voorwaardelijkheden	Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-KIN-1 is toevertrouwd. Deze EPA bouwt voort op de activiteiten daarin omschreven
CanMEDS	☒ Vakinhoudelijk handelen ☒ Communicatie ☒ Samenwerking ☒ Kennis en wetenschap ☒ Maatschappelijk handelen ☒ Leiderschap ☒ Professionaliteit
Kennis	● Anatomie, fysiologie en pathologie van de te opereren aandoening bij een kind van 0-18 jaar ● Veel voorkomende chirurgische ingrepen binnen de verschillende specialismen ● Pre- en postoperatieve zorg, incl. postoperatieve complicaties ● Observatiemethodieken rondom chirurgische ingreep (zoals pijnscore, SBARR, PEWS en ABCDE) ● Voeding, vocht en uitscheiding rondom de chirurgische ingreep ● Anesthesie, verdovingstechnieken en werking ● Farmacologie rondom de chirurgische ingreep ● Kwaliteitsrichtlijnen specifiek voor het kind (o.a. VMS-thema's) ● Protocollen, richtlijnen en leefregels voor en na de operatie
Vaardigheden en gedrag	**Vaardigheden:** ● Handelen volgens geldende protocollen/richtlijnen ● Opname en/of overname van het kind en de ouders/verzorgers en het verzamelen van gegevens ● Kind en gezin informeren over en begeleiden in de algemene procedures rondom de operatie

	● Herkennen van angst, pijn en stress en uitvoeren van interventies om deze te reduceren ● Toepassen van de principes en benaderingswijze van ontwikkelingsgerichte en gezinsgerichte zorg ● Methodisch observeren, analyseren en beredeneren van de zorgsituatie (pre- en postoperatief). Op basis van klinisch redeneren prioriteiten stellen en hiernaar handelen ● Uitvoeren van pre- en postoperatieve zorg ● Klaarmaken en toedienen medicatie, infusie ● Anticiperen op mogelijke veranderingen in de vitale functies ● Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen in het kader van de chirurgische ingreep ● Uitvoeren van wondzorg ● Voorkomen, herkennen van en anticiperen op complicaties ten gevolge van de chirurgische ingreep ● Organiseren en coördineren van de uitvoerende zorg ● Interprofessioneel communiceren, samenwerken en zorg afstemmen ● Evalueren en bijstellen van de verpleegkundige zorg ● Afronden van en/of overdragen van zorg intra- en extramuraal **Gedrag:** ● Laat voorbeeldgedrag zien ● Toont empathie ● Reflecteert op eigen handelen in de specifieke zorgsituatie ● Kent de eigen verantwoordelijkheid als gespecialiseerd verpleegkundige en de grenzen hiervan ● Staat open voor feedback ● Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp ● Werkt nauwkeurig
Toetsinstrumenten	Leeromgeving: • I.V. medicatie via infuuspomp klaarmaken en toedienen • I.V.: Spuit infuuspomp Argus • I.V.: Volumepomp: Argus Certificaat Pijnscore Mondeling of schriftelijk uitwerking van 4 ziektebeelden. Keuze uit: • Schisis, Appendicitis, Invaginatie, Pneumothorax, Navel- of Liesbreuk, Circumcisie Torsio testis, Klompvoet, Heupdysplasie, Fracturen, Adenotomie, Tonsillectomie, Myringoplastiek, Orthopedische operaties KPE/Feedback/CBD: minimaal 6; aan de orde moet komen • Opname + voorbereiden + ontslag van geplande OK • Opname + voorbereiding + ontslag van acute OK Reflectieverslag van stagedag op SEH (1 dag)
Fase en niveau	De verwachting is dat de student deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden.

Titel	MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie (KERN)
Versie	definitief, © maart 2022
Specificaties & beperkingen	Het betreft: ● Het zorg verlenen aan een kind (0-18 jr) waarbij de vitale functies zijn verstoord, die geobserveerd en bewaakt worden ● De kans op vitale bedreiging is aanwezig waarbij de vitale functies (in o.a. ABCDE) ondersteund worden ● Er is voldoende reactie op de geboden therapie Beperkingen: ● Het betreft niet het kind met intensieve ondersteuning(ondersteunende non invasieve beademingsvormen) ● Het betreft niet de (kortdurende) overname van een vitale functie ● Het betreft niet het ondersteunen vitale functies in alle orgaansystemen 'verder' dan high flow respiratoir **Specificaties:** Dit is een kern-EPA voor KIN, HC-K en IC-K **De activiteit omvat:** ● Voorbereiden, controleren van de omgeving en instellen van (bewakings)-apparatuur, hulpmiddelen, materialen en medicatie ● Uitvoeren van de opname en/of overname van de zorg en daarbij het verzamelen van relevante gegevens over het kind en gezin met de(hetero-) anamnese ● Observeren, meten en bewaken van vitale functies ● Analyseren, beredeneren en interpreteren van alle verzamelde gegevens m.b.v. de ABCDE Methodiek en op basis van klinisch redeneren prioriteren van zorg ● Bewaken en zo nodig ondersteunen van de ademhaling (t/m max. high flow respiratoir) ● Signaleren van verslechtering of verbetering op somatisch en/of psychosociaal vlak (kind en gezin) ● Assisteren bij onderzoek en of medische handelingen ● Prioriteren en waar mogelijk bundelen van lichamelijke zorg (in relatie tot de vitale toestand van het kind) in afstemming met kind en ouders ● Ondersteunen, begeleiden, voorlichten van kind en gezin rekening houdend met coping strategieën van ouders/naasten conform gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg ● Prioriteren, uitvoeren, evalueren, bijstellen en rapporteren van de verpleegkundige zorg en therapie ● Coördineren van zorg bij het inschakelen van andere disciplines ● Voorbereiden en/of uitvoeren van intern transport t.b.v. diagnostiek en behandeling ● Voorbereiden en/of uitvoeren van een eventuele overplaatsing naar HC/IC of ander ziekenhuis ● Interprofessioneel samenwerken, waaronder communiceren en zorg afstemmen ● Methodisch overdragen of afronden van de zorg
Voorwaardelijkheden	Deze EPA kan worden afgerond wanneer KIN 1 toevertrouwd is
CanMEDS	☒ Vakinhoudelijk handelen ☒ Communicatie ☒ Samenwerking ☒ Kennis en wetenschap ☒ Maatschappelijk handelen ☒ Leiderschap ☒ Professionaliteit ☒ Professionaliteit
Kennis	● Anatomie, fysiologie: normaalwaarden vitale functies bij kinderen in de verschillende ontwikkelingsfasen ● Pathofysiologie: grenzen en afwijkende waarden van de vitale functies (bedreiging in alle orgaansystemen passend bij de leeftijd en zorgsituatie) ● Methodieken om de mate van vitale bedreiging vast te stellen, zoals ABCDE methodiek en PEWS ● Diagnostiek, behandeling en onderzoeken (en op basis van bevindingen):

	● o.a. zuurbase evenwicht/bloedgassen, monitorbewaking, thoraxdrainage, low-flow, high-flow, gebruik non-rebreathing masker/oxymask, luchtweg obstructie/keel-neus toilet, parenterale voeding ● Farmacologie passend bij de zorgsituatie
Vaardigheden en gedrag	**Vaardigheden:** ● Klaarmaken, instellen en controleren van medische- en/of verpleegkundige bewakingsapparatuur en materialen ten behoeve van ondersteuning vitale functies ● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens/informatie ● Maken van contact/stimuleren van interactie en afstemmen van communicatie op het denk- en ontwikkelniveau van het kind in relatie tot het ziekteproces ● Methodisch observeren, meten en bewaken van vitale functies, toepassen van de ABCDE methodiek vervolgens analyseren en verbanden leggen onderlinge orgaansystemen en hiernaar handelen ● Ondersteunen vitale functies (somatisch) volgens medisch beleid/protocollen ● Anticiperen op (mogelijke) veranderingen in de zorgsituatie in overleg met de arts ● Klaarmaken en toedienen medicatie ● Signaleren van de vitale bedreiging en op basis hiervan prioriteiten stellen en interventies toepassen, rekening houdend met de leeftijd en zorgsituatie ● Uitvoeren van resuscitatie volgens de PBLS-richtlijnen ● Toepassen van verpleegtechnische vaardigheden ● Begeleiden en ondersteunen van het kind bij lichamelijke verzorging, indien van toepassing in afstemming met ouders ● Informeren van het kind en ouders over en begeleiden bij onderzoeken zoals bloedgasanalyse, bloedafname, kweken, lumbaalpunctie en röntgenonderzoek ● Begeleiden van kind/ouders bij therapie en interventies zoals inname medicatie (sonde, peg, IV, inhalatie), monitoring, neus-keel toilet bij obstructie, zuurstoftoediening, infuustherapie, thoraxdrainage en ademhaling-ondersteunende therapie t/m high flow ● Informeren en begeleiden van kind en ouders/naasten in verbeterende/ verslechterende zorgsituatie conform ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg ● Ondersteunen op het psychosociaal welbevinden van het kind en gezin ● Interprofessioneel communiceren (bijv. met SBARR), samenwerken en zorg afstemmen ● Organiseren, coördineren, evalueren, bijstellen en rapporteren van de zorg ● Afronden van of methodisch overdragen van zorg **Gedrag:** ● Is stressbestendig en kan onder tijdsdruk presteren ● Is alert en werkt nauwkeurig ● Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp ● Anticipeert op snelle veranderingen in de zorgsituatie ● Kan reflecteren op eigen handelen in de specifieke zorgsituatie ● Kent de eigen verantwoordelijkheid als gespecialiseerd verpleegkundige en de grenzen hiervan ● Staat open voor feedback ● Herkent ethische dilemma's en maakte deze bespreekbaar en hanteerbaar binnen het interprofessionele team
Toetsinstrumenten	Leeromgeving: • Medicatie klaarmaken • Beademing: Cpap Fabian Therapy • Beademing: Fabian acutronic +nCPAP Mondeling of schriftelijk uitwerking van 3 ziektebeelden. Keuze uit: • BLWI, Pneumonie, Bronchitis, Laryngitis, Anemie, ASD,VSD, Meningitis, Open ductus KPE/Feedback/CBD: minimaal 6 Productbeoordeling: bv.: klinische les, folder ontwikkelen, zorgplan, CAT, PICO

Fase en niveau	De verwachting is dat de student deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden.
Titel	MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag-/midden complexe zorgvraag (KERN)
Versie	definitief, © maart 2022
Specificaties & beperkingen	Het betreft het verlenen van zorg aan een kind met een interne aandoening in de volgende context: ● Interne aandoening zonder co morbiditeit en waarbij de vitale functies niet bedreigd zijn ● Onder interne aandoeningen vallen alle chronische en acute aandoeningen die 'niet snijdend' behandeld worden ● Kind (0-18 jaar) ● Ouders/gezin rondom het kind ● Intra- en extramurale setting De activiteit omvat: ● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens specifiek gericht op het kind met een intern gezondheidsprobleem ● Het afnemen van een (hetero)anamnese specifiek gericht op het kind met een intern gezondheidsprobleem ● Methodisch observeren, meten en beredeneren/interpreteren van de vitale functies van het kind en op basis daarvan handelen ● Voorlichting geven aan kind en gezin met betrekking tot het ziektebeeld ● Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de kinderverpleegkundige zorg aan een kind o.b.v. ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg ● Overdragen/Indiceren van zorg en samenwerken met collega's binnen het intra- en multidisciplinaire netwerk
Voorwaardelijkheden	Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-KIN-1 is toevertrouwd. Deze EPA bouwt voort op de activiteiten daarin omschreven.
CanMEDS	☒ Vakinhoudelijk handelen ☒ Communicatie ☒ Samenwerking ☒ Leiderschap ☒ Professionaliteit ☒ Kennis en wetenschap ☒ Maatschappelijk handelen
Kennis	● Pathologie van interne aandoeningen bij een kind van 0-18 jaar ● Specifieke verpleegkundige zorg van interne aandoeningen bij een kind van 0-18 jaar ● Farmacologie gericht op interne aandoeningen ● Integrale kindzorg en gezinsgerichte zorg specifiek gericht op interne zorgvraag ● Wet- en regelgeving rondom indicatiestelling (zoals Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Jeugdwet, Persoonsgebonden budget en Wet maatschappelijke ondersteuning)
Vaardigheden en gedrag	**Vaardigheden:** ● Handelen volgens geldende protocollen/richtlijnen ● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens ● Maken van een zorgplan in samenspraak met kind en gezin ● Afstemmen van communicatie met het kind en ouders, rekening houdend met de ontwikkelings- en leeftijdsfase van het kind ● Informeren en begeleiden van kind, ouders en gezin tijdens het ziekteproces ● Methodisch observeren, analyseren en beredeneren van de zorgsituatie. Op basis van klinisch redeneren prioriteiten stellen en hiernaar handelen ● Anticiperen op mogelijke veranderingen in de vitale functies ● Voorkomen, herkennen van en anticiperen op complicaties tgv de ziekte of behandeling ● Toepassen van de principes en benaderingswijze van ontwikkelingsgerichte- en gezinsgerichte zorg ● Klaarmaken en toedienen van medicatie en infusie ● Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen ● Anticiperen op de sociale situatie van kind en gezin en op mogelijke veranderingen hierin ● Organiseren en coördineren van de uitvoerende zorg ● Interprofessioneel communiceren, samenwerken en zorg afstemmen ● Evalueren en bijstellen van de verpleegkundige zorg

	● Afronden van en/of overdragen van zorg intra- en extramuraal **Gedrag:** ● Laat voorbeeldgedrag zien ● Toont empathie ● Kan reflecteren op eigen handelen in de specifieke zorgsituatie ● Kent de eigen verantwoordelijkheid als gespecialiseerd verpleegkundige en de grenzen hiervan ● Staat open voor feedback ● Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp ● Werkt nauwkeurig
Toetsinstrumenten	Leeromgeving: • Toediening medicatie als bolus of oplossing bij kinderen • I.V. medicatie via infuuspomp klaarmaken en toedienen • I.V.: Spuit infuuspomp Argus • I.V.: Volumepomp: Argus • Maagkatheter inbrengen en verwijderen bij kinderen • Voedingspomp: Flocare Infinity Nutricia • Mondeling of schriftelijk uitwerking van 3 ziektebeelden. Keuze uit: • Astma, Koortsconvulsie, Epilepsie, Obesitas, Diabetes, Allergieën, UWI, Infectie, Reflux, Dehydratie KPE/Feedback/CBD: minimaal 6 Verslag MDO Reflectieverslag van stage op de poli Kindergeneeskunde (2 dagen) Productbeoordeling; a.d.v EBP opdracht
Fase en niveau	De verwachting is dat de student deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden.

Titel	MK-KIN-4 Zorg verlenen aan een kind met psychosociale, psychosomatische of psychiatrische problematiek (KERN)
Versie	definitief, © maart 2022
Specificaties & beperkingen	Het betreft het zorg verlenen aan het kind met zowel psychosociale, psychosomatische of psychiatrische, soms in combinatie met lichamelijke problematiek, waarbij het accent ligt op het observeren van gedrag, het geven van advies en instructie en dit vertalen naar een verpleegkundig behandelplan in afstemming met het interprofessioneel behandelteam in de volgende context: ● Problematiek zoals onverklaarbare buikpijn, conversieklachten en regressie ● Intra- en extramurale setting ● Kind tussen 0-18 jaar in alle ontwikkelingsfasen ● Ouders/gezin rondom het kind De activiteit omvat: ● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens specifiek gericht op de psychosociale, psychosomatische of psychiatrische problematiek ● Het afnemen van een (hetero)anamnese specifiek gericht op de het kind in deze context ● Observeren en signaleren van (afwijkend) gedrag van kind en gezin met psychosociale, psychosomatische of psychiatrische problematiek en dit vertalen naar de zorgvraag en op basis daarvan handelen ● Herkennen en bespreekbaar maken van ethische dilemma's ● Ondersteunen van het kind en de ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making ● Geven van voorlichting aan kind en gezin met betrekking tot een psychosomatische, psychosociale of psychiatrische problematiek ● Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de kinderverpleegkundige zorg aan een kind in deze context o.b.v. ontwikkelings- en kindgerichte zorg ● Overdragen/indiceren van zorg en samenwerken met collega's en binnen het intra- en multidisciplinaire netwerk
Voorwaardelijkheden	Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-KIN-1 is toevertrouwd. Deze EPA bouwt voort op de activiteiten daarin omschreven.
CanMEDS	☒ Vakinhoudelijk handelen ☒ Communicatie ☒ Samenwerking ☒ Kennis en wetenschap ☒ Maatschappelijk handelen ☒ Leiderschap ☒ Professionaliteit
Kennis	● Specifieke aandoeningen en behandelingen van psychosomatische, psychosociale en psychiatrische problematiek ● Communicatiemethodieken (zoals omgaan met weerstand, motivatieproblematiek, manipulatief gedrag en gedragsverandering) ● Ethische vraagstukken bij kind en gezin
Vaardigheden en gedrag	**Vaardigheden:** ● Werken volgens de geldende wet- en regelgeving, beroepscode voor verpleegkundigen en protocollen of richtlijnen ● Zorgdragen voor opname en het verzamelen van gegevens van het kind en ouders ● Maken van een zorgplan in samenspraak met kind en ouders ● Anticiperen op mogelijke veranderingen in de zorgsituatie (somatisch en psychosociaal), proactief handelen en inschakelen overige disciplines ● Afstemmen van communicatie met het kind en ouders, rekening houdend met de ontwikkelings- en leeftijdsfase van het kind ● Toepassen van de principes en benaderingswijze van ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg in relatie tot de psychosomatische, psychosociale of psychiatrische problematiek ● Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld en hier actief op handelen ● Interprofessioneel communiceren, samenwerken en zorg afstemmen ● Organiseren, coördineren en uitvoeren van zorg ● Evalueren en bijstellen van de verpleegkundige zorg

	● Leveren van een bijdrage aan de ethische besluitvorming met betrekking tot de diagnostiek, behandeling en de zorg voor kind en gezin door actief te participeren in het interprofessionele team ● Afronden en/of overdragen van zorg intra- en extramuraal **Gedrag:** ● Toont empathie ● Kan reflecteren op eigen handelen in de specifieke zorgsituatie ● Maakt ethische dilemma's in relatie tot eigen normen en waarden binnen het interprofessionele team bespreekbaar en hanteerbaar ● Kent de eigen verantwoordelijkheid als gespecialiseerd verpleegkundige en de grenzen hiervan ● Toont stressbestendigheid en vraagt tijdig om hulp ● Staat open voor feedback ● Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp
Toetsinstrumenten	Leeromgeving: • Werken met meldcode (verpleegkundigen kinderafdeling) Schriftelijk uitwerking van 1 ziektebeeld met betrekking op psychosomatische, psychosociale of psychiatrische problematiek na goedkeuring van praktijkbegeleider Reflectieverslag van stage Ipse de Bruggen(2 dagen) KPE/Feedback/CBD: minimaal 5 Analyse t.a.v. zorgethiek volgens het stappenplan. Je kunt hierbij denken aan; kindermishandeling, NAS , ouderschap tekort of andere ethische casus naar keuze. Het stappenplan, hoe je een ethisch dilemma kunt ontrafelen, leer je in de lessen zorgethiek. Maak de opdracht na het volgen van de les.
Fase en niveau	De verwachting is dat de student deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden.